

Rastreamento · vs diagnóstico precoce

Rastreamento busca doença em assintomáticos; diagnóstico precoce investiga sintoma. Em prova, cobre critérios de um bom programa e vieses de lead time/length time.

Rastreamento "vs" diagnóstico precoce

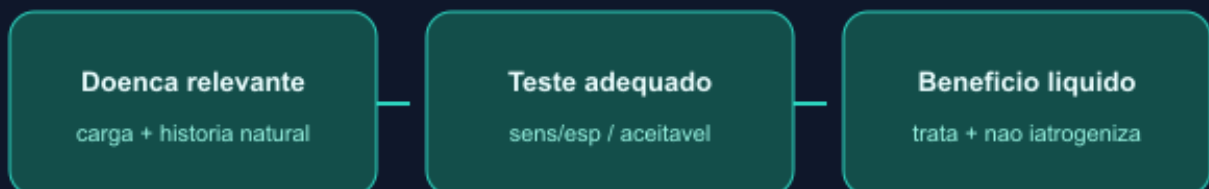
Lembre - Rastreamento "vs" diagnóstico precoce

Rastreamento: população assintomática (ex.: mamografia de rotina). Diagnóstico precoce: paciente com sinal/sintoma (ex.: nódulo palpável !' investigação).

Fluxo conceitual: problema relevante !' teste aceitável !' tratamento que muda desfecho sem dano excessivo.

Rastreamento em 3 ideias

Doença importante -> teste útil -> benefício líquido



Crítérios clássicos (Wilson-Jungner — ideia)

- Doença importante e com fase latente detectável
- Teste sensível, específico, aceitável e seguro
- Tratamento eficaz disponível e custo aceitável
- Processo contínuo, não 'mutirão sem seguimento'

Vieses que caem em prova

Viés | Ideia

Lead time | Diagnóstico mais cedo sem alongar sobrevida real

Length time | Rastreio pega tumores lentos (melhor prognóstico aparente)

Seleção | Quem adere ao rastreio já é diferente

Sobrediagnóstico | Detecta o que não ia adoecer clinicamente

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Teste com alta sensibilidade não justifica rastreamento sozinho. Sem tratamento que melhore desfecho (ou com muitos falsos positivos), o programa pode só gerar dano e custo.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1